Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
4ª Vara Cível da Comarca de Santa Maria

Rua Alameda Buenos Aires, 201 - Bairro: Nossa Senhora das Dores - CEP: 97050545 - Fone: (55) 3222-8888 - Email: frsantmari4vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5029829-92.2023.8.21.0027/RS

AUTOR: ANELISE OKASESKI GOMES
ADVOGADO(A): ERICK ANDERSON DIAS KOBI (OAB ES027525)

RÉU: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADO(A): MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA (OAB PE023748)

SENTENÇA

Vistos.

ANELISE OKASESKI GOMES ajuizou "***ação de obrigação de fazer***" contra **CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL**

Alegou ser portadora de esclerose múltipla progressiva (CID 10 G.35) e, em razão da afecção, é cometida por "*dificuldade de marcha, dores generalizadas, fadiga crônica, diplopia (a percepção de 2 imagens de um único objeto), dificuldade cogniva, parestesia (sintomas sensoriais anormais geralmente caracterizadas por comichão, formigamento ou sensação de ardência) e hipoestesia (diminuição de sensibilidade) nos membros inferiores, entre outros sintomas que lhe traz grande prejuízo na sua qualidade de vida por prejudicar suas avidades de vida diária e diminuir sua funcionalidade.*" Em razão disso, explicou, foi-lhe receitado o medicamento Fampyra (princípio ativo: fampridina), para auxiliar na capacidade de deambular, e Venvanse (dimesilato de lisdexanfetamina), para a fadiga – ambos de alto custo. A demandada, com quem mantém plano de saúde, porém, negou-se a fornecer esses medicamentos, apontando que "*não há cobertura contratual para os medicamentos com base na Lista de Materiais Descartáveis e Medicamentos Abonáveis CASSI (LIMACA).*" Defendeu que essa negativa é ilícita, pois cabe ao médico assistente, não ao convênio, estabelecer o tratamento do paciente, sob pena de inviabilizar o propósito da contratação. Logo, sustentou que, "*se determinada doença é abrangida pelo plano contratado, é dever da operadora fornecer e custear o tratamento indicado pelo médico responsável pelo paciente. O contrato não pode se furtar daqueles tratamentos cujas doenças estão cobertas pelo plano, caracterizando uma 'meia-cobertura'.*" Requereu a concessão de tutela de urgência para determinar à ré o oferecimento dos medicamentos mencionados. No mérito, postulou a condenação do réu ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente no fornecimento dos medicamentos, e ao pagamento de indenização por danos morais.

Recebida a inicial e **deferida** a gratuidade da justiça (3.1). **Indeferida** a tutela de urgência. Inconformada, a parte autora intepôs **agravo de instrumento**, ao qual foi negado provimento (processo 5321640-85.2023.8.21.7000/TJRS, evento 22, ACOR2).

A parte ré foi **citada** (17.1).

Designada **audiência de conciliação**, não foi possível compor amigavelmente o litígio (23.1).

A ré apresentou **contestação** (27.2). Preliminarmente, apontou que o pedido seria genérico, implicando inépcia; e impugnou o valor da causa. No mérito, disse não haver cobertura legal ou contratual para medicamentos de uso domiciliar, como aqueles prescritos à autora. Defendeu que esse tipo de custo cabe ao paciente, excedendo o escopo do plano de saúde. Refutou a existência de dano moral. Por esses motivos, pediu a extinção ou improcedência da ação.

Houve **réplica** (33.1).

Intimadas, as partes expressaram desinteresse na abertura de instrução.

Vieram os autos conclusos para sentença.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Estando o feito estreme de vícios formais, passo ao julgamento antecipado da lide, pois a matéria é exclusivamente de direito (artigo 355, I, do Código de Processo Civil).

1. DAS PRELIMINARES DE MÉRITO

1.1 Por primeiro, afasto a preliminar de **inépcia da inicial**. Conquanto o pedido "h"[1] da inicial contenha, de fato, fração indeterminada (expressa pelo adjunto "enquanto for necessário"), a situação dos autos amolda-se à exceção do artigo 324, II, do Código de Processo Civil. Com efeito, sendo a moléstia que acomete a autora progressiva e, em princípio, incurável, não é possível determinar, desde logo, quanto tempo o tratamento que vindica lhe será útil, ou quando seu médico assistente haverá de alterar sua prescrição. Seria isensato fixar termo à tutela, seja pelo estabelecimento apriorístico de termo final em data ou período certos – o que só faria repetir desnecessariamente o litígio em caso de subsistência da situação após

o decurso do prazo – ou vinculação a condição resolutiva, tal como a duração da vida da autora – o que engessaria seu tratamento, impedindo a alteração da abordagem clínica. Nesse caso, a formulação de pedido indeterminado não é apenas legalmente admissível como também é o proceder mais lógico.

1.2 As demais considerações da parte ré, relacionadas à necessidade de reavaliação periódica do estado do paciente no caso de tratamento de longa duração, dizem respeito ao mérito da causa e às peculiaridades da tutela a ser concedida, se for o caso, e não aos requisitos formais da inicial. Em outras palavras: é lícito que o autor demande a condenação em obrigação *sine die*, independentemente de reavaliação clínica; isso não significa que o pedido haja de ser acolhido tal como formulado. Do mesmo modo, a falta de prova documental de algum fato é tema de mérito, não implicando inépcia da inicial.

1.3 A **impugnação ao valor da causa** há de ser igualmente rejeitada. A demandante atribuiu à ação valor equivalente ao preço anual estimado do tratamento[2] (artigo 292, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil), somada (292, VI, mesmo diploma) ao valor da indenização por danos morais[3] (292, V, mesmo diploma). Os valores do tratamento foram estimados com base em orçamentos (1.19, 1.20) de fornecedores idôneos, o que basta para estimar o valor da causa.

2. DO MÉRITO

2.1 O caso é de improcedência da ação pelos mesmos motivos já expostos nos eventos 3.1 e em nada alterados pelo posterior andamento da causa – isso a despeito dos relevantes esforços da parte autora em suas manifestações subsequentes.

Inicio por esclarecer que **não se está a discutir se a esclerose múltipla é afecção coberta (sim, é), ou se o tratamento foi prescrito à autora por seu médico assistente e é adequado** (foi e é); esses temas nem sequer são controversos. Também não se discute se a demandante empreendeu ou não demonstrar os requisitos do artigo 10, § 13, da Lei 9.656/98 para cobertura de tratamento não previsto no rol da ANS – o tema é irrelevante, já que **(a)** os medicamentos foram aprovados para tratamento da moléstia da demandante; e **(b)** não é esse o ponto de controvérsia. Por fim, não é controverso que há prescrição do médico assistente.

O ponto fulcral, e a matéria *sub judice*, é saber se a demandada está ou não obrigada à **cobertura de medicamento de uso domiciliar sem caráter antineoplásico**. A resposta é negativa, pelos mesmos motivos considerados na decisão que indeferiu a tutela provisória, da qual cito:

> *[...]*
>
> *No caso, a parte autora demonstrou ser beneficiária de plano de saúde mantido pela ré (evento 1, OUT7), bem como o diagnóstico da doença (evento 1, ATESTMED10) e prescrições médicas indicando o uso dos medicamentos (evento 1, LAUDO8 e evento 1, LAUDO11).*
>
> *Entretanto, não há dúvida de que são **medicamentos** **de uso domiciliar e contínuo** e, portanto, não há obrigatoriedade de cobertura, nos termos do artigo 10, VI, da Lei 9.656/98, que transcrevo:*
>
> > *Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:*
> >
> > *I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental;*
> >
> > *II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim;*
> >
> > *III - inseminação artificial;*
> >
> > *IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética;*
> >
> > *V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados;*
> >
> > ***VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12;***
> >
> > *VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico;*
> >
> > *IX - tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou não reconhecidos pelas autoridades competentes;*
> >
> > *X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela autoridade competente.*
> > *[destaquei]*
>
> *Não se discute, aqui, tratamento clínico domiciliar (que seria coberto), mas apenas a medicação, sobre a qual há **expressa ressalva legal**, com exceção dos casos de antineoplásicos domiciliares de uso oral (artigo 12, I, 'c'; e II, 'g' da mesma lei). **Os medicamentos de uso domiciliar prescritos à demandante** (fampridina/Fampyra e dimesilato de lisdexanfetamina/Venvanse**) não são antineoplásicos e, portanto, não estão obrigatoriamente cobertos.** Nesse sentido:*
>
> > *APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO NÃO REGULAMENTADO. AÇÃO DE COBRANÇA. **MEDICAMENTO PARA CONTROLE DA DOR. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DO DEVER DE COBERTURA** Trata-se de ação de cobrança, através da qual a parte autora busca o ressarcimento dos valores gastos com a compra de medicamentos utilizados para fins de controle da dor, cuja cobertura foi negada pela requerida, julgada improcedente na origem. No caso dos autos, é incontroverso que a parte autora mantinha junto a requerida contrato particular de prestação de serviços médicos e hospitalares, na categoria não regulamentado, firmado em agosto de 1989 (evento 8 outros2), bem como que já tinha se submetido a tratamento de Neoplasia de Bexiga (CID C67). O contrato de plano de saúde firmado entre as partes, tem cláusula expressa de exclusão - cláusula 3 "l" quanto à coberturas*

médicas e exames diagnósticos, ademais conforme cláusula 2 - 2.1, possui disposição quanto ao reembolso de determinadas despesas médicas. Segundo o laudo médico acostado no evento 1 atest medico 6 e outros 7, o autor necessitava dos seguintes medicamentos para controle da dor: Durogesic trans; Zolpidem; Pregabalina; Mythedon e Novalgina. ***O tratamento reclamado, que é administrado por via oral, caracteriza-se como despesa não coberta – medicamento fora do regime de internação hospitalar*** *– conforme explícita cláusula de exclusão contratual descrita nas condições gerais da apólice. Mesmo que a apólice fosse adaptada à Lei 9656/98 (o que não restou demonstrado), ainda assim, as despesas com a administração da medicação reclamada seria objeto de exclusão, porquanto, em conformidade com recentes julgados do egrégio STJ, verifica-se que restou consolidado que é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art.17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021).Sentença mantida.APELAÇÃO DESPROVIDA(Apelação Cível, Nº 50169697920208210022, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 31-08-2023)*
[destaquei]

Logo, a demandada só estaria obrigada à cobertura se houvesse expressa previsão contratual nesse sentido *– e, no caso da CASSI, o artigo 18 do regulamento admite a concessão de "assistência farmacêutica para aquisição de materiais descartáveis e medicamentos de uso domiciliar" desde que estejam contemplados na "Lista de Materiais Descartáveis e Medicamentos Abonáveis CASSI – LIMACA" (artigo 18, V, 'a', do regulamento). Como os medicamentos vindicados pela demandante não constam desse rol, não há obrigação de a ré custeá-los. Em se tratando de cláusula que amplia as coberturas obrigatórias legais, em caráter excepcional, não há como, ainda que em benefício do consumidor, desconsiderar os limites clara e expressamente fixados para essa exceção.*

Pelo exposto, ***INDEFIRO*** *a tutela provisória requerida.*

De fato, a Lei 9.656/98 desobriga os planos de saúde do "*fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12*" (antineoplásicos). **Os medicamentos prescritos à demandante (a) não são antineoplásicos e (b) são, incontestavelmente, de uso domiciliar, sem ligação com procedimento ambulatorial ou ato cirúrgico.** Logo, por desbordarem o escopo das obrigações do plano de saúde, cabe ao paciente custeá-los. Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CUSTEIO. OPERADORA. NÃO OBRIGATORIEDADE. ANTINEOPLÁSICO ORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LIMITAÇÃO LÍCITA. CONTRATO ACESSÓRIO DE MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. SUS. POLÍTICA PÚBLICA. REMÉDIOS DE ALTO CUSTO. RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME).
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia a definir se medicamento de uso domiciliar (no caso, Viekira Pak, utilizado no tratamento de Hepatite-C), e não enquadrado como antineoplásico oral, é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde.
3. ***É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021).***
4. ***Os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico e adquiridos comumente em farmácias não estão, em regra, cobertos pelos planos de saúde.***
5. As normas do CDC aplicam-se apenas subsidiariamente nos planos de saúde, conforme previsão do art. 35-G da Lei nº 9.656/1998.
Ademais, em casos de incompatibilidade de normas, pelos critérios da especialidade e da cronologia, há evidente prevalência da lei especial nova.
6. A previsão legal do art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 não impede a oferta de medicação de uso domiciliar pelas operadoras de planos de assistência à saúde (i) por liberalidade; (ii) por meio de previsão no contrato principal do próprio plano de saúde ou (iii) mediante contratação acessória de caráter facultativo, conforme regulamentação da RN nº 310/2012 da ANS.
7. No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a assistência farmacêutica está fortemente em atividade, existindo a Política Nacional de Medicamentos (PNM), garantindo o acesso de fármacos à população, inclusive os de alto custo, por meio de instrumentos como a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME).
8. Recurso especial provido.
(REsp n. 1.692.938/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 4/5/2021.)
[destaquei]

Pouco se altera pelo mero argumento de que, havendo prescrição do medicamente pelo médico assistente, a cobertura seria obrigatória se a moléstia que a motivou o fosse. Ocorre que a interpretação é flagrantemente absurda, já que, excetuados os medicamentos OTC ("*over the counter*", de venda livre), todos os demais são prescritos por médicos ou dentistas; assim entender faria letra-morta da exclusão expressa do já citado artigo 10, VI, Lei 9.656/98, tornando os planos de saúde efetivos responsáveis pelo custeio de todos os fármacos que exigem receita. Esse resultado atenta contra os mais comezinhos princípios de hermenêutica jurídica.

2.2 Por fim, sendo lícita a negativa de cobertura, não há falar em indenização por danos morais. É sabido que a responsabilidade civil depende, em essência, da conjunção de três pressupostos: **a ocorrência de um ato ilícito culposo, a existência de um dano injusto e a relação de causalidade entre o primeiro e o segundo requisitos.**

Um **ato**, para o propósito de responsabilização civil extracontratual, deve incorrer em ilicitude absoluta, como já advertida Pontes de Miranda: "*os ato ilícitos, que aqui* [na disciplina da responsabilidade extracontratual] *tratamos, são os atos ilícitos absolutos, e não os atos ilícitos relativos, cuja ilicitude concerne à vinculação negocial que se infringiu*".[4] Ou seja: exige-se tratar-se de ato ilícito *stricto sensu*, consistente naquele em que alguém imputável, por culpa *lato sensu*, produz dano ou causa prejuízo a terceiro. No caso de responsabilidade contratual, o simples inadimplemento (absoluto ou relativo), por si só, caracteriza ato ilícito e resulta no dever de indenizar, nos termos dos artigos 389 e 395 do Código Civil.

Sem ato ilícito absoluto ou relativo – como no caso dos autos –não há responsabilidade civil, portanto.

DISPOSITIVO

Em razão do exposto, **JULGO IMPROCEDENTES** os pedidos formulados por ANELISE OKASESKI GOMES contra CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL para, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, resolver o mérito.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixo em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade dessas verbas de sucumbência em razão do benefício da gratuidade da justiça.

Sentença publicada pelo lançamento de documento digital no sistema **eproc**. Desnecessário o registro. Intimem-se.

Sobrevindo recurso(s) de **embargos de declaração**, dê-se vista à parte oposta, por cinco dias. Depois, voltem para análise.

Interposto(s) **recurso(s) de apelação**, dê-se vista à(s) parte(s) apelada(s) para, em quinze dias, apresentar(em) contrarrazões. Caso haja recurso adesivo ou suscitação de questões preliminares (artigo 1.009, § 1º, do Código de Processo Civil) em contrarrazões, dê-se vista ao(s) apelante(s) por novos quinze dias, para manifestação. Concluídas as intimações e decorridos os prazos, remeta-se o feito ao E. Tribunal de Justiça.

Com o **trânsito em julgado**, certifique-se pelo lançamento do correspondente movimento no sistema **eproc**. Após, nada mais sendo requerido, e não subsistindo pendências, dê-se baixa.

Documento assinado eletronicamente por **LUCIANO BARCELOS COUTO, Juiz de Direito**, em 14/11/2024, às 18:1:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10072017357v25** e o código CRC **f047c5dc**.

---

1. "h) No Mérito, requer que seja julgada procedente a ação, raficando a liminar concedida e deferindo a condenação da Requerida ao fornecimento do tratamento médico da Requerente com os medicamentos Fampridina/Fampyra e Dimesilato de lisdexanfetamina/Venvanse, conforme prescrições anexas, enquanto for necessário, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);" ↩
2. R$ 2.157,88 mensais ou R$ 25.894,56 por ano. ↩
3. R$ 20.000,00. ↩
4. In Tratado de Direito Privado, vol. 53, p. 81. ↩